

إسم المريض رابعياً : هاله شعبان محمد عبدالمنعم

المحافظة : القاهرة
 الحي / المدينة : البساتين
 رقم البطاقة : 27608030100727 رقم التليفون : 01145239255
 العمر(تاريخ الميلاد) : 03-08-1976 المهنة : اعمال صيانه

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة
[11129]

التعليق على التشخيص : -----

الاسم: د/محمد كيلاي
 الاسم: د/ندي حسن
 الاسم: د/نرمين رمضان
 الوظيفة: _____
 الوظيفة: _____
 الوظيفة: _____
 التوقيع: _____
 التوقيع: _____
 التوقيع: _____
 تعتمد صحة البيانات المرفقة
 رئيس اللجنة ومدير
 المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

----- / 2 ----- / 2 ----- / 2.1 ----- / 2.1

التشخيص النهائي :
 خطة العلاج :
 المستشفى : قسم :
 جهة العلاج : نفقات :
 ملاحظات :

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: هالة شعبان محمد عبد المنعم National ID: 27608030100727	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



٢٠٢١/٠٧ ٢٧٦.٨.٣.١.٠٧٢٧

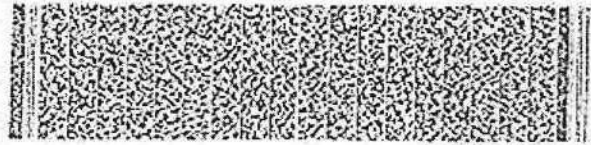
حاصلة على دبلوم تجارة



أنثى مسلمة متروجة

سامي محمد تقديم جزين

البيانات سارية حتى ٢٠٢٨/٠٧/٢٨



جمهورية مصر العربية
وزارة الداخلية
إدارة شئون المصريين بالخارج

هـ

شعبان محمد عبد المنعم

٩ من مصطفى كامل بن الجمهورية
البساتين - القاهرة

٢٧٦.٨.٣.١.٠٧٢٧

121315072



MDT form

Form No. MDT/1/2024

1. Name: [Name]

Sex: [Sex]

2. Medical history
Present: [Present]

3. Date of MDT: [Date]

4. Place: [Place]

5. Ref. No.: [Ref. No.]

6. Date of Birth: [Date]

7. Date of MDT: [Date]



8. Ref. No.: [Ref. No.]

9. Ref. No.: [Ref. No.]

10. Ref. No.: [Ref. No.]

11. Ref. No.: [Ref. No.]

12. Ref. No.: [Ref. No.]

13. Ref. No.: [Ref. No.]

14. Ref. No.: [Ref. No.]

15. Ref. No.: [Ref. No.]

16. Ref. No.: [Ref. No.]

17. Ref. No.: [Ref. No.]

18. Ref. No.: [Ref. No.]

19. Ref. No.: [Ref. No.]

20. Ref. No.: [Ref. No.]

21. Ref. No.: [Ref. No.]

22. Ref. No.: [Ref. No.]

23. Ref. No.: [Ref. No.]

Breast Imaging:

1. Breast multifocal or multicentric process with pathological axillary nodes: [Status]

Clinical data

2. Metastasis: [Status]

DX	ER	PR	Her 2 Neu	SISH	Ki67
10C	8/8	5/8	3		25

T	N	M
4B	2	0

Sonomammography

PATIENT HISTORY

pt received TCHP 18 wks TC+ 7 cycles HP
on exam still large breast mass t3, amalgamated axilla -> AC x4
STILL LOCALLY ADVANCED
LT HRM: IDC GII with focal DCIS
free margins, nipple, areola
ypT3 N2 (LN 5/8) partial pathological response

MDT OUTCOME & PLAN

FOR PORT TO LT CW, SC, AXILLA, INC
ADJ Ax 5-10 years (follow up E2 level every 3months)
Adjuvant Kadcyla x 10 cycles

MEDICAL ONCOLOGY

SURGERY

PSYCHIATRIC

SIGNATURE

RADIOLOGY

PATHOLOGY

NOTATION

Name: هاله شعبان محمد عبد المنعم		
MR. : 6603		
Detailed Medical Report		
		السيد
تجبة طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه The patient is a 49-year-old with a primary left-breast carcinoma, initially staged as clinical T4B N2 M0 with estrogen-receptor expression 6/8, progesterone-receptor expression 7/8, and HER2-positive disease (3+). The patient underwent left modified radical mastectomy on 11/2/2025 and subsequently received adjuvant therapy consisting of KADCYLA 260 mg and FEMORA beginning in March 2025 for a planned C12 regimen. The patient was prescribed FEMORA calcium 1 tablet daily for 90 days, along with ONE ALPHA ZOLAEX 10.8 mg subcutaneously as a single dose in January 2026, with the medication provided free for CT CAP. The patient reports new onset trigeminal neuralgia; magnetic resonance imaging of the brain was ordered to evaluate this symptom while the patient continues on FEMORA and ZOLADEX for a duration of three months. The current plan is to assess imaging results and manage the neuralgia accordingly.		
تحريرا في ,		
	التاريخ :	19-09-2026
	الوقت :	
	dina makram	الطبيب المعالج :
يعتمد ,		



Patient Name	: الأستاذة / هالة شعبان محمد عبدالمنعم	Request No.	: 13001912
Patient No.	: 27608030100727	Request Date	: 12/02/2025
Path No.	: 628/25	Verification Date	: 03/03/2025
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 48 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer post NACT .
Nature of the specimen: Left breast & Left axilla (MRM)

Gross Examination:

- Procedure: Left MRM
- measured 25x20x6 cm with covering skin ellipse measured 20x16 cm .
- Localization: UOQ
- Tumor extent : A greyish white tumour bed site
- Size: 14 x10 x5 cm .
- Skin involvement: Nipple & areola were unremarkable grossly .
- Distance from margins: 2 cm away from deep margin , 0.5 cm away from the skin .
- Axilla: Fibrofatty tissue piece measured 8x8 cm entangling 7 nodules up to 3x3 cm
- Microscopic examination:
- Histological type: Invasive duct carcinoma (Actual tumour size 14x10 cm , Cellularity 80%)
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)
- Ductal carcinoma in situ: Focal (5%)
- Skin involvement: Free nipple and areola
- Lymph node involvement: Positive L.Ns (4/7)+intramammary lymph node (1/1)= total nodal count 5/8
- Resection Margins: Free margins , DEEP MARGIN showed lymphovascular emboli
- Histologic response to therapy: Pathologic partial response

Diagnosis:

Left MRM (post NACT) :

Invasive duct carcinoma grade II with focal DCIS

- Free margins (deep margin was free of invasive tumor or DCIS , ONLY SHOWED LYMPHOVASCULAR EMBOLI
- Free nipple and areola

Verified by :

Dr.Heba Hasan

Printing Date : 13/03/2025 11:14:49

Page 1 of 2

Printing By : hermal



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt



Patient Name : الأستاذ / هالة شعيبان محمد عبدالمنعم

Patient No. : 27608030100727

Path No. : 628/25

Sex : Female

Age : 48 Y

Referreing Doc :

Request No. : 13001912

Request Date : 12/02/2025

Verification Date : 03/03/2025

Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام

Department : Out Patient

Registered by : .marwa mohamed youss

Pathology Report

- Positive L.Ns (5/8)
- Pathologic partial response
- Stage : ypT3, ypN2
- RCB : 4.476 , RCB class III

Signature

Dr. Rana Fathy

Dr.Heba Hassan

Verified by :

Dr.Heba Hasan

Printing Date : 13/03/2025 11:14:49

Page 2 of 2

Printing By : hermal



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department



وزارة الصحة
مستشفى دار السلام
قسم الأشعة

Patient Name: Hala Shaaban Mohamed Abd Al Moneim	Date : 13/03/2025
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 48 Year(s)
Medical ID: 1447/2024	Pat. ID: 53576

Targeted ultrasound on left operative bed and axilla

Indication:

- Patient with left MRM few weeks ago

Report:

- Still noted left axillary level II interpectoral (Rotter's) lymph node showing extra-capsular rupture, measured 12x13mm (was 7x10mm in prior study dated 19/1/2025), BIRADS 6
- Free supra-clavicular regions.
- Operative bed seroma nearly occupying the whole lateral aspect of the operative bed, measured roughly 2x6cm

Signature Dr. Engy Abdallah
13/03/2025 12:59 PM

ECHO REPORT

Name: فالح سعيد

Date: 30 / 9 / 2025

EF	66%	55-75%	PWT	1.1	0.6-1.1cm
LVEDD	4.9	3.5-5.8cm	AO.R	2.5	2-3.7cm
LVESD		2-4cm	LA	3.5	2-4cm
FS		25-45%	RV		0.7-2.3cm(supine)
SWT	1.2	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

LV dimensions normal

LV wall thickness increased

LV diastolic function DD grade I

SWMA normal

LA and Ao root dimensions normal

Mitral Valve normal

Aortic valve normal

Tricuspid valve mild TR

Pulmonary valve normal

Right side and systolic function normal

Intracardiac masses and effusion normal

Eccentric LVH

DD grade I

Dr /
J. Al-Hadi



٢٠٢١/٠٧ ٢٧٦.٨.٣.١.٠٧٢٧

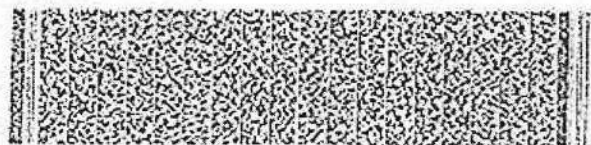
حاصلة على دبلوم تجارة



أنثى مسلمة متروجة

سامي محمد تقديم جزين

البيانات سارية حتى ٢٠٢٨/٠٧/٢٨



جمهورية مصر العربية
وزارة الداخلية
إدارة شئون المصريين بالخارج

هذه

شعبان محمد عبد المنعم

٩ من مصطفى كامل شن الجمهورية
البسنتين - القاهرة

٢٧٦.٨.٣.١.٠٧٢٧

121315072



MDT form

Form No. MDT/1

1. Name: [Name]

Sex: [Sex]

2. Medical history: [History]

3. Date: [Date]

4. Time: [Time]

5. Ref. No.: [Ref. No.]

6. Date of Birth: [Date of Birth]

7. Date of MDT: [Date of MDT]



8. Ref. No.: [Ref. No.]

9. Date: [Date]

10. Name: [Name]

11. Date: [Date]

12. Time: [Time]

13. Reason for MDT: [Reason for MDT]

14. Ref. No.: [Ref. No.]

15. Date: [Date]

16. Name: [Name]

17. Date: [Date]

18. Time: [Time]

19. Date of MDT: [Date of MDT]

20. Ref. No.: [Ref. No.]

21. Date: [Date]

22. Name: [Name]

23. Date: [Date]

24. Time: [Time]

25. Date of MDT: [Date of MDT]

Clinical data

Breast Imaging:

1. Breast multifocal or multifocal process with pathological axillary nodes: [Status]

Mets Workup:

free

DX	ER	PR	Her 2 Neu	SISH	Ki67
IOC	8/8	5/8	3		25

T	N	M
4B	2	0

Sonomammography

PATIENT HISTORY

pt received TCHP 18 wks TC+ 7 cycles HP
on exam still large breast mass t3, amalgamated axilla -> AC x4
STILL LOCALLY ADVANCED
LT HRM: IDC GII with focal DCIS
free margins, nipple, areola
ypT3 N2 (LN 5/8) partial pathological response

MDT OUTCOME & PLAN

FOR PORT TO LT CW, SC, AXILLA, INC
ADJ AX 5-10 years (follow up E2 level every 3months)
Adjuvant Kadcyla x 10 cycles

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY

SURGERY

PSYCHIATRIC

RADIOLOGY

PATHOLOGY

Notation



Patient Name	: الأستاذة / هالة شعبان محمد عبدالممنع	Request No.	: 13001912
Patient No.	: 27608030100727	Request Date	: 12/02/2025
Path No.	: 628/25	Verification Date	: 03/03/2025
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 48 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer post NACT .
Nature of the specimen: Left breast & Left axilla (MRM)

Gross Examination:

- Procedure: Left MRM
- measured 25x20x6 cm with covering skin ellipse measured 20x16 cm .
- Localization: UOQ
- Tumor extent : A greyish white tumour bed site
- Size: 14 x10 x5 cm .
- Skin involvement: Nipple & areola were unremarkable grossly .
- Distance from margins: 2 cm away from deep margin , 0.5 cm away from the skin .
- Axilla: Fibrofatty tissue piece measured 8x8 cm entangling 7 nodules up to 3x3 cm
- Microscopic examination:
- Histological type: Invasive duct carcinoma (Actual tumour size 14x10 cm , Cellularity 80%)
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)
- Ductal carcinoma in situ: Focal (5%)
- Skin involvement: Free nipple and areola
- Lymph node involvement: Positive L.Ns (4/7)+intramammary lymph node (1/1)= total nodal count 5/8
- Resection Margins: Free margins , DEEP MARGIN showed lymphovascular emboli
- Histologic response to therapy: Pathologic partial response

Diagnosis:

Left MRM (post NACT) :

Invasive duct carcinoma grade II with focal DCIS

- Free margins (deep margin was free of invasive tumor or DCIS , ONLY SHOWED LYMPHOVASCULAR EMBOLI
- Free nipple and areola

Verified by :

Dr.Heba Hasan

Printing Date : 13/03/2025 11:14:49

Page 1 of 2

Printing By : hermal



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt



Patient Name : الأستاذة / هالة شعيبان محمد عبدالمنعم

Patient No. : 27608030100727

Path No. : 628/25

Sex : Female

Age : 48 Y

Referreing Doc :

Request No. : 13001912

Request Date : 12/02/2025

Verification Date : 03/03/2025

Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام

Department : Out Patient

Registered by : .marwa mohamed youss

Pathology Report

- Positive L.Ns (5/8)
- Pathologic partial response
- Stage : ypT3, ypN2
- RCB : 4.476 , RCB class III

Signature

Dr. Rana Fathy

Dr.Heba Hassan

Verified by :

Dr.Heba Hasan

Printing Date : 13/03/2025 11:14:49

Page 2 of 2

Printing By : hermal



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department



وزارة الصحة
مركز التخصص
مستشفى دار السلام
إدارة الأشعة

Patient Name: Hala Shaaban Mohamed Abd Al Moneim	Date : 13/03/2025
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 48 Year(s)
Medical ID: 1447/2024	Pat. ID: 53576

Targeted ultrasound on left operative bed and axilla

Indication:

- Patient with left MRM few weeks ago

Report:

- Still noted left axillary level II interpectoral (Rotter's) lymph node showing extra-capsular rupture, measured 12x13mm (was 7x10mm in prior study dated 19/1/2025), BIRADS 6
- Free supra-clavicular regions.
- Operative bed seroma nearly occupying the whole lateral aspect of the operative bed, measured roughly 2x6cm

Signature Dr. Engy Abdallah
13/03/2025 12:59 PM

ECHO REPORT

Name: د. محمد

Date: 30 / 9 / 2025

EF	66%	55-75%	PWT	1.1	0.6-1.1cm
LVEDD	4.9	3.5-5.8cm	AO.R	2.5	2-3.7cm
LVESD		2-4cm	LA	3.5	2-4cm
FS		25-45%	RV		0.7-2.3cm(supine)
SWT	1.2	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

LV dimensions normal

LV wall thickness increased

LV diastolic function DD grade I

SWMA normal

LA and Ao root dimensions normal

Mitral Valve normal

Aortic valve normal

Tricuspid valve TR

Pulmonary valve normal

Right side and systolic function normal

Intracardiac masses and effusion normal

Concentric LVH

DD grade I

Dr /
J. Alkhalaf